Método clínico, historia clínica y técnicas de exploración

SEMIOLOGIA · Clase 05 · de la palabra del paciente a las manos del médico, y de ahí al diagnóstico

1 · ESCUCHAR, EXAMINAR, PENSAR: SÍNTOMA, SIGNO Y SÍNDROME

Interrogatorio
lo que el paciente cuenta: panel 1 de la imagen, solo con la palabra

Exploración física
lo que el examinador reconoce con la vista, las manos y el estetoscopio

da a conocer los

reconoce los

Síntoma
manifestación subjetiva que refiere el paciente: «tengo disnea»

Signo
manifestación objetiva que reconoce el examinador: edema, cianosis

se agrupa con síntomas en el

se agrupa con signos en el

Síndrome
síntomas y signos que van juntos: orienta, aún no es una enfermedad

se hace mediante la → Anamnesis

sigue un orden fijo → Orden del examen

2 · LA ENTREVISTA Y EL ORDEN DE LA HISTORIA CLÍNICA

F1 · Anamnesis
viene de «recordar»; su instrumento es la palabra: no hay aparato en el panel 1

exige una buena

F2 · Actitud del médico
se presenta, guardapolvo, habla sin tecnicismos; deja narrar y luego pregunta; un responsable si el paciente no puede

la primera pregunta clínica es el

F3 · Motivo de consulta
«¿cuál es su problema?»: con las palabras del paciente y máximo 3 síntomas

se completa con el

F4 · Tiempo de enfermedad
≤ 10 días: agudo; > 60 días: crónico (📚 astenia: crónica > 6 meses)

se desarrolla en la

Enfermedad actual
¿cómo inició?, ¿cómo evolucionó?, ¿cómo está ahora?

se completa con la

Revisión de sistemas
de la cabeza a los pies: atrapa lo que el paciente no contó

cierra la anamnesis y sigue el

F5 · Orden de la historia clínica
anamnesis, examen físico, resumen, consideraciones diagnósticas, plan, evolución, pronóstico, epicrisis

si se hace mal produce la

F6 · Historia mal elaborada
es la causa más frecuente de error diagnóstico: todo lo que sigue se desvía

al integrar los datos abre los → Síndrome

3 · DEL SÍNDROME A LOS CUATRO DIAGNÓSTICOS

F7 · Síndrome coledociano
ictericia, acolia y coluria (+ prurito)

se explica por el

F7 · Colédoco obstruido
la bilis no llega al intestino: heces claras; la bilirrubina vuelve a la sangre: piel y orina amarillas (imagen 3)

un ejemplo clásico es el → Cuatro diagnósticos

F8 · Cuatro diagnósticos
capas del mismo caso (el banco dice cinco, CAFES; tu docente, cuatro)

capa 3: la lesión

capa 2: el mecanismo

capa 1: la forma

capa 4: la causa

F8 · 1 · Sindrómico
forma clínica: síndrome edematoso

F8 · 2 · Funcional
mecanismo: retención hidrosalina

F8 · 3 · Anatómico
lesión: glomeruloesclerosis

F8 · 4 · Etiológico
causa: diabetes

suma al

suma al

suma al

el conjunto queda como

luego se golpea con la → Diagnóstico presuntivo

Diagnóstico presuntivo: los exámenes complementarios lo confirman, descartan o modifican

4 · EL EXAMEN FÍSICO: VER Y PALPAR

Orden del examen
inspección, palpación, percusión, auscultación; en el abdomen se ausculta antes de palpar

empieza por la inspección con

se complementa con la

F9 · Condiciones de la inspección
buena iluminación (mejor natural), descubrir solo la región y conocer lo normal

Palpación
nueve variantes; antes: manos tibias y uñas cortas

para dolor y edema usa la

para la temperatura usa el

F10 · Digitopresión
pulpejo del pulgar o índice: busca dolor, circulación cutánea y fóvea

al comprimir un edema deja la

con la palpación forma el

F11 · Dorso de la mano
piel fina, sensible al calor: mide la temperatura

aporta un dato único: el

F10 · Signo de la fóvea
el hoyo que deja la presión: edema

confirma el edema y suma al

Cada técnica aporta un dato que las otras no pueden dar

5 · PERCUTIR Y AUSCULTAR: NORMAL FRENTE A PATOLÓGICO

Percusión de Gerhardt
el dedo medio derecho golpea la 2.ª falange del medio izquierdo (plexímetro); se valora sonido y resistencia

si hay aire en los alvéolos suena

si hay aire libre suena

si el aire es escaso suena

si no hay aire suena

por último se escucha con el → Auscultación

F12 · F13 · Claro
aire en los alvéolos: tórax sano

por eso el sonido es el

si el aire queda atrapado hay

F12 · F13 · Hipersonoridad
claro exagerado por aire atrapado en el tórax patológico: enfisema, asma

por eso el sonido es el

F12 · F13 · Timpánico
aire libre: intestino, espacio de Traube; en el tórax, neumotórax

por eso el sonido es el

F12 · F13 · Mate
sin aire: muslo, deltoides; sobre el pulmón orienta a derrame

por eso el sonido es el

F12 · F13 · Submate
aire escaso: hígado cubierto por pulmón

por eso el sonido es el

El sonido traduce la estructura
claro = aire alveolar; submate o mate = aire escaso o ausente; timpánico = aire libre

Auscultación
estetoscopio: campana 2,5 cm (graves, 3.er y 4.º ruido); diafragma 3-3,5 cm

sus hallazgos cierran el

junto con la auscultación cierra el

Los signos se suman a los síntomas y vuelven al síndrome, base del razonamiento

técnica · síntoma · signo · síndrome · concepto · desenlace · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor — teoría del docente: 01, 02a, 02c, 03, 03b (📚 = literatura)